

新冠新变异株“蝉”



绰号为“蝉”（Cicada）的新冠新变异株（BA.3.2）近期在包括美国25个州在内的全球多地出现。之所以得名，是因为它像蝉一样蛰伏一年多后，于2026年春季突然活跃。

它具有高突变特征，在刺突蛋白区有70多个突变，而且容易免疫逃逸，现有疫苗和既往感染产生的抗体几乎没有保护作用。但其毒性及致病力均无明显增强，临床上主要表现为上呼吸道感染：咽痛、咳嗽（最常见），还有发热、乏力、肌肉酸痛、流涕等。

“蝉”变异株虽然传播较快，但并未导致住院率和重症率显著上升，目前只是新冠病毒的一次常规小规模演化，无需过度恐慌。

美国麻疹疫情最新动态

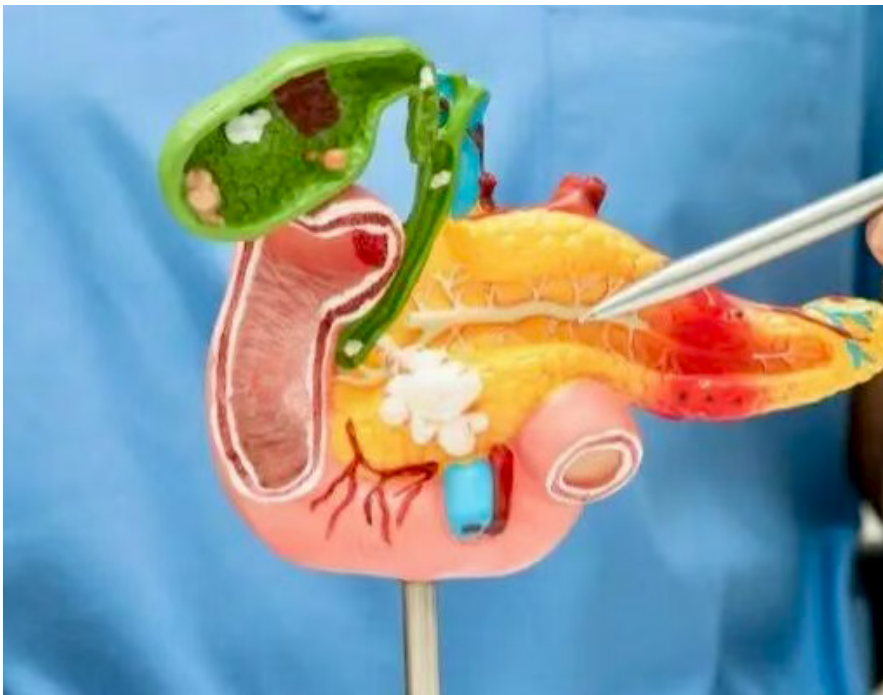
全美麻疹疫情目前处于“高位平台期”，虽然传播范围广，但增长速度正趋于平缓。

2026年全美已报告 1,748例 确诊病例，波及 33个 州及管辖区，爆发集中地：犹他州（当前震中，400+例）和南卡罗来纳州（600+例）。92% 的感染者未接种疫苗，以青少年及儿童多见占比超 70%。约 6% 的患者需住院治疗，今年尚无死亡报告。好消息是近一周仅新增 7 例，增长速度降至今年最低点。

专家建议：检查 MMR 疫苗接种记录。如出现高热+红疹，请先致电医生再前往诊所，以防交叉感染。

医学进展

胰腺癌治疗取得重大突破



Revolution Medicines 公司最近宣布其在研药物 Daraxonrasib（代码：RMC-6236）在治疗胰腺癌的全球三期临床试验中取得了巨大成功。这款新药在针对常规化疗失败后的晚期胰腺癌患者身上表现出了前所未有的效果：总生存期由常规治疗的6.7个月增加到13.2个月，让生存期“翻倍”。而且该药将患者的死亡风险降低了约 60%。这是全球首个在三期临床中证明能让晚期胰腺癌患者生存期超过一年的靶向药物。Daraxonrasib 是一种广

谱 RAS 抑制剂，它通过同时抑制多种常见的 RAS 突变，精准锁定并关闭癌细胞内的肿瘤“生长开关”。

用mRNA 疫苗治疗胰腺癌初步显示疗效

最新公布的一期临床试验结果，发现胰腺癌患者在接受mRNA疫苗注射后可产生免疫应答反应，表现为持续的 T 细胞活性，而且明显延长胰腺癌患者的无病生存期。这是一种针对胰腺导管腺癌（PDAC）的个性化 mRNA 疫苗，它根据每位患者肿瘤独特的基因突变“量身定制”，旨在诱导免疫系统攻击癌细胞。这一结果尚有待正在进行的2/3期临床试验证实。

又一口服GLP-1减肥药被批准上市



继诺华公司口服Wegovy片剂批准后，FDA最近又正式批准了礼来公司的口服GLP-1药物 orforglipron上市（商品名：Foundayo），均可用于肥胖或超重合并相关疾病人群的长期体重管理。Foundayo平均减重约11—12%，但可以随时服用，不受进食影响；Wegovy 平均减重14—16%，但需空腹服用、且服后30分钟不能进食。

脂蛋白与冠心病发病有关

最近发表在美国心血管疾病杂志（JACC）的孟德尔随机化研究，证实 脂蛋白Lp(a) 对冠心病（CAD）具有显著的直接因果效应，且这种影响独立于低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）之外。此外，Lp(a) 暴露增加与糖化血红蛋白（HbA1c）水平升高有直接关联。该研究进一步明确Lp(a) 可作为心血管疾病的独立风险因素，测定Lp(a) 水平可以为临床提供了更精准的风险评估。

每日健康

日常防过敏手册



春季是过敏人群最“难熬”的时候。花粉、尘螨、霉菌等过敏原在这个季节明显增加，容易诱发鼻炎、哮喘、结膜炎、皮炎等。

常见过敏原

- 花粉：尤其是树木（橡树、桦树）和草类花粉
- 尘螨：室内床垫、枕头、地毯中常见
- 霉菌：潮湿环境中容易滋生
- 宠物皮屑：猫狗毛发、皮屑中的蛋白

特点是空气传播、肉眼难见，但致敏能力强

常见症状

- 鼻部：打喷嚏、流清水鼻涕、鼻塞（典型过敏性鼻炎）
- 眼部：眼痒、流泪（过敏性结膜炎）
- 呼吸道：咳嗽、喘息（可能诱发哮喘）
- 皮肤：瘙痒、红疹（如荨麻疹、湿疹）

防护策略



1. 减少接触：从“源头”控制

- 花粉高峰（清晨、傍晚）尽量错峰外出
- 外出佩戴口罩、眼镜（物理屏障很有效）
- 回家后及时洗脸、洗手、更换衣物
- 避免在室内开窗通风时间过长

2. 打造“低过敏”环境

- 使用HEPA空气净化器
- 每周用热水（ $\geq 55^{\circ}\text{C}$ ）清洗床单被套
- 减少地毯、毛绒玩具等“藏尘”物
- 控制湿度（40—50%），防止霉菌滋生

3. 个人防护小习惯

- 外出可以考虑戴口罩
- 户外回来用自来水或盐水冲洗鼻腔
- 不用手揉眼睛（避免加重炎症）
- 适度运动，但避免高花粉时段
- 充足睡眠，减轻免疫系统“过度反应”

4. 饮食调节

- 多摄入富含维生素C的水果（如橙子、猕猴桃）
- 增加Omega-3脂肪酸（如深海鱼）
- 避免已知食物过敏源（如海鲜、坚果等个体差异）

药物使用

如果症状明显，可考虑：

- 第二代抗组胺药（如 Loratadine）
- 鼻用激素喷雾（效果稳定）
- 每天预防性应用，效果会更好

注意：老人、儿童、孕妇及慢病患者的药物最好应在医生指导下使用。

择时就医

- 症状持续超过2周未缓解
- 出现发烧、喘息、呼吸困难
- 反复发作影响睡眠或工作
- 怀疑食物或药物严重过敏

小结

春季过敏并不可怕，关键在于“提前预防 + 日常管理”。

本期专题

AI 正在进入放射医学：机遇、挑战与底线

最近，美国纽约多家大型医院高层公开表示，若监管允许，人工智能（AI）可以在部分场景中替代放射科医生完成影像初步诊断，也就是说AI将要开始替代医生了。这一表态迅速在医学界、商业圈、公众及病人间引发较大争议。

其实争议的核心并不是“AI 能不能处理影像”，而是：AI 在现代放射医学中究竟处于什么地位？

技术层面：AI 的确已经“非常能干了”

实际上，AI 在某些标准化影像识别上，已经达到甚至部分超过人类医生水平。这不是未来，而是现在。

最成熟的领域是标准化筛查。在“筛查并发现异常”这件事上，AI已经非常强大，目前AI表现最好的领域包括：

- 🫁 肺结节筛查
- 🧠 脑出血识别
- 🧡 乳腺癌筛查
- 🫁 胸片异常分诊

这些任务的共同点是：

- ✓ 标准化
- ✓ 目标明确（有/没有异常）
- ✓ 数据量巨大

AI可以做到：

- 快速筛查
- 自动标记异常
- 提醒医生优先处理

医院为什么这么积极推动AI？

说得直白一点：不是因为“技术先进”，而是因为要“降低成本”。

成本压力

放射科是医院中成本较高的科室之一：

- 医生培养周期长
- 人力成本高
- 夜班负担重

AI可以降低这些压力

影像需求爆炸

现代医学越来越依赖影像检查：

- CT、MRI、PET-CT数量持续增长
- 医生却不够用

AI被视为解决“人不够”的工具

效率惊人

AI可以：

- 自动写报告初稿
- 标记异常区域
- 优先排序危急病例

本质上：提升效率，而非完全替代

医学界怎么看？

医学界并不反对AI，但坚决反对“完全替代”。

主流共识：AI 是助手，不是医生

为什么反对“替代”？

因为放射科医生并不仅仅是“看图机器”，而是需要做：临床推理、多信息整合、风险判断等。比如说：一个影像上的“阴影”，可能是：炎症、良性病变、癌症。此时，放射科医生需要结合具体病人的病史、症状、实验室检查、随访变化等综合考虑进行鉴别诊断，而目前的AI在这些方面仍明显不足。

患者是否安全？

这是最核心的问题。

1) AI最危险的错误是漏诊。不是“看错”，是没有看见。例如：早期癌症漏掉、小出血漏掉等，但后果可能致命

2) AI在不同医院表现不稳定：原因包括有设备不同、人群不同、数据不同。实验室或科研的表现 $\neq$ 真实世界/临床表现

3) 过度信任AI（隐形风险）

如果AI说“没问题”，医生可能降低警惕。这叫：自动偏见（automation bias）。此外，还有因数据大小、来源不同而导致的系统偏见。

4) AI可能在某些人群表现较差。如少数族裔、罕见病患者、特殊居住环境的患者。

伦理与法律：目前最大空白

如果AI出错，谁负责？ 可能涉及：医生、护士、医院或者AI公司

病人是否需要被告知？ AI参与诊断是否应明确告知患者？并获得知情同意？

此外，AI诊治还涉及医疗公平问题

AI的真正位置

AI擅长：找异常、快速筛查、提高效率、降低成本。

AI不擅长：复杂诊断、临床整合、风险决策、承担责任等。

所以，AI可以帮医生“看见”，但还不能替医生“做判断、负责任”。

给普通人的建议

- 不必恐慌：AI不会马上替代医生
- 可以放心：AI正在提高医疗效率
- 但要知道：最终为你负责的仍然是医生。

结尾金句

未来不是“AI取代医生”，而是“不会用AI的医生，被会用AI的医生取代”。

橄榄树基金给您的健康提醒：

春季来到，天气变暖，是户外活动的好季节。请走出去、动起来！

百花竞放，如果你有季节性过敏，请尽早开始使用喷鼻剂及抗组胺药加以预防。

户外活动增加，请注意不要受伤。

橄榄树健康咨询感谢您的关注及分享

